

HERNIE DIAPHRAGMATIQUE

I Definition

Hernie Diaphragmatique: Passage permanent ou intermittent d'un ou plusieurs viscères abdominaux dans le thorax par un orifice diaphragmatique anormal

- ☐ Orifice congénital malformatif -hernie congénitale
- ☐ Orifice acquis (rupture diaphragmatique)
- ☐ Orifice physiologique anormalement large (hernie hiatale)
Pas d'orifice anormal mais diaphragme flasque, hypoplasique

II Embryologie

La hernie diaphragmatique congénitale est une malformation précoce puisque le développement du diaphragme se produit entre 4 semaines et 8 semaines de la gestation on distingue

- Hernie diaphragmatique à travers le foramen de Bochdalek= secondaire à un défaut de musculation du diaphragme situé entre les parties costales et lombaires (12^{ème} cotes)
- Hernies diaphragmatiques par la fente de Larrey zone de faiblesse naturelle sur la partie antérieure du diaphragme entre les fibres musculaires du chef costal et chef sternal du diaphragme laissant passage à l'artère et la veine épigastriques supérieures
- Hernies diaphragmatique acquise Passage à travers l'orifice hiatal d'une partie de l'estomac

III Diagnostic positif

1 Circonstances de découverte

- découverte fortuite
- détresse respiratoire Dyspnée, douleur thoracique pneumopathies, troubles digestifs (pyrosis regurgitation)

2 Examen clinique: pauvre

cyanose, tirage, polypnée
Thorax bombé Déviation du bruit du cœur

3 Radiologie:

Radiographie du thorax opacité: opacité homogène arrondie surmontant la coupole diaphragmatique

Scanner thoracique identifie la nature de la hernie

IRM (intéressante): montre la hernie et le défaut du diaphragme

IV Variétés d'hernies diaphragmatiques

-
Plusieurs variétés d'hernies diaphragmatiques

1 Hernies Hiatales

Désigne le passage de la partie supérieure de l'estomac dans le thorax à travers l'orifice hiatal du diaphragme

- Affection fréquente
- La plupart se développe avec l'âge et la fragilité des tissus
- Hernie par glissement/ par roulement/ mixtes
- Hernie par glissement: 85% des cas
 - augmente avec l'âge, la plus fréquente
 - Liée à une altération progressive des moyens de fixation du cardia à l'hiatus œsophagien, en particulier la membrane phréo-œsophagienne
- Hernie par roulement: 5%
 - L'estomac mais aussi (colon, épiploon, rate) peuvent être ascensionnés dans le thorax à travers l'orifice hiatal (large)
 - Danger : volvulus gastrique et conséquences ischémiques; Le volvulus gastrique aigu complication la plus grave des HH par roulement. Dans ce cas, la quasi-totalité de l'estomac peut se retrouver volvulée dans le thorax avec un risque majeur de nécrose ischémique et de perforation, et donc de médiastinite.
- Hernies hiatales mixtes 10%

Les hernies hiatales sont classées en différents types :

- * Type 1 : Hernies par glissement
- * Type 2 : Hernies par roulement
- * Type 3 : Hernies mixtes (par glissement et roulement)
- * Type 4 : Hernies avec un autre organe abdominal ascensionné dans le médiastin

Les hernies de type 1 n'ont pas de sac herniaire à la différence des types 2, 3, ou 4 qui possèdent un sac péritonéal herniaire.

2 Hernies congénitales antérieures

- ☐ Incidence : 1 et 6 % des hernies diaphragmatiques.
- ☐ La hernie intéresse soit la fente de Marfan médiane soit la fente de Larrey antérieure entre les faisceaux xiphoïdiens et les faisceaux d'insertion chondro-costaux retro xiphoidienne
- ☐ 70-90% du côté droit (Hernie de Morgani) (masse cardiaque gauche)
- ☐ Gauche (rare): hernie de la fente de Larrey
- ☐ Bilatérales (7%)
- ☐ Le sac herniaire est quasi-constant avec un contenu essentiellement épiploïque et colique transverse, rarement (pancréatique/ hépatique)

- ❑ Habituellement découverte chez l'enfant devant un tableau aigu mais peuvent parfois passées inaperçues + diagnostiquée chez l'adulte.
- ❑ Souvent asymptomatiques (70-80%)/ découverte fortuite

3 Hernies congénitales posterolaterale

- Hernies congénitales /incidence 1cas/3200
- 60-90 % des cas des hernies congénitales
- (Associées à d'autre malformations abdominale, thoracique ou médiastinale dans 25 à 50 % des cas
- Prédominance à gauche 85%
- Découverte tardive à l'âge adulte est rare (5%)
- La présence d'un Hydramnios ou de malformations fœtales doivent faire systématiquement rechercher une hernie congénitale
- f. néonatale: pronostic vital mis en jeu en cas d'hypoplasie pulmonaire associée
- Diagnostic période anté-natale : échographie de dépistage (12 à 18 SA)

V Traitement

1 Objectif

Réduire la hernie et rétablir l'étanchéité du diaphragme

2 Moyens

chirurgicaux par laparotomie ou laparoscopie avec réduction de la hernie avec raphie du defect par suture ou mise en place d'une prothèse

3 Indications

a) En urgence

- nouveau né en cas de détresse respiratoire
- Quelque soit l'âge en cas de volvulus gastrique

b) Situation élektive :

- hernie asymptomatique : abstention thérapeutique
- hernie symptomatique : traitement chirurgical

*Médical : stabilisation préopératoire

- Réanimation cardio-respiratoire
- Jamais de ventilation au masque ++
- Oxygénation+ ventilation assistée haute fréquence
- Monoxyde d'azote
- Oxygénation extra-corporelle ECMO

*Chirurgical

- L'indication chirurgicale est posée en urgence dans les formes néonatales. Elle est justifiée dans tous les cas (chez l'enfant et chez l'adulte) en raison du risque de complications sévères.

* L'occlusion trachéale par ballonnet : qui doit être mis entre 26 SA et 28 SA et retiré à 34 SA, il empêche les liquides pulmonaires de ressortir par la bouche permettant d'augmenter le volume pulmonaire

* Si l'abord thoracique est décrit, l'abord abdominal est généralement préféré en situation d'urgence comme en chirurgie réglée.

*Réintégrer les organes herniés

* Fermer le defect diaphragmatique suture transversale au fils non résorbable

*Rechercher les malformations digestives

* La mise en place d'une prothèse largement appliquée sur le diaphragme et fixée par des points ou des agrafes peut être nécessaire, notamment chez l'adulte.

* Un drainage aspiratif de la cavité thoracique est laissé en place

- Lors d'une laparotomie: suture
- Lors d'une contusion de la base du thorax: meilleur contexte d'exploration c'est par abord abdominal
 - ❖ Rupture découverte tardivement
 - Voies d'abord en fonction de l'ancienneté des troubles (8 EIC)
 - ❖ Étranglement herniaire
 - Abord thoracique si étranglement aigu parfois associé à un abord abdominal

- Pathologie rare chez l'adulte
- Incidence entre 0,2 et 1 pour /1000 adultes
- Prédominance à gauche dans 80% des cas et plus fréquente homme
- Retentissement respiratoire est classique en raison de la respiration paradoxale
- Les formes droites sont le plus souvent asymptomatiques (découverte à imagerie++)
- Forme gauche triade
- ❑ Dextrocardie après déplacement vers la droite du cœur qui est refoulé par les viscères abdominaux herniés dans le thorax
-